



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete do Secretário

INFORME TÉCNICO Nº 01/2025

MANEJO CLÍNICO DA DESIDRATAÇÃO INFANTIL EM SITUAÇÕES DE CALOR INTENSO

Dezembro 2025

Informe Técnico

MANEJO CLÍNICO DA DESIDRATAÇÃO INFANTIL EM SITUAÇÕES DE CALOR INTENSO

Dezembro 2025

Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES-RJ

Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Claudia Maria Braga de Mello

Subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde

Mário Sérgio Ribeiro

Superintendente de Atenção Primária à Saúde

Halene Cristina Dias de Armada e Silva

Subsecretária Geral

Rachel Rivello Elmor

Superintendente de Educação em Saúde

Fernanda Daniel Moraes Fialho

Coordenadora da Área Técnica da Saúde da Criança

Roberta Rodrigues da Costa Serra

Organização

Área Técnica da Saúde da Criança

Comitê Estadual de Prevenção da mortalidade Infantil e Fetal SES/RJ

Superintendência de Educação em Saúde

Elaboração Técnica

Roberta Rodrigues da Costa Serra

Fernanda Moraes Daniel Fialho

Revisão Técnica

Roberta Rodrigues da Costa Serra

Fernanda Moraes Daniel Fialho

Projeto gráfico

Ascom

Elaboração, distribuição e informações

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

1. PÚBLICO ALVO

Pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospitais Estaduais e Emergências Pediátricas.

2. CONTEXTO

Com as temperaturas elevadas no verão fluminense, as crianças apresentam maior vulnerabilidade ao **estresse térmico**. A perda hídrica ocorre não apenas por via gastrointestinal, mas por sudorese intensa e taquipneia (perda insensível), levando rapidamente à desidratação hipertônica ou isotônica.

3. DESIDRATAÇÃO

É a redução significativa da quantidade de água do corpo, e geralmente está associada a alteração de eletrólitos também.

A desidratação continua a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade em lactentes e criança menores no mundo todo. Lactentes são particularmente suscetíveis aos efeitos deletérios da desidratação por suas maiores necessidades hídricas basais (por terem taxa metabólica mais elevada), perda por

evaporação maior (por causa da maior relação da área de superfície:volume) e incapacidade para comunicar sede ou procurar líquidos.

4. PRINCIPAIS CAUSAS DE DESIDRATAÇÃO:

- Perda de líquido aumentada
- Ingestão de líquidos diminuída
- Ambos

A causa mais comum da perda de líquidos é por alterações no trato gastrointestinal — por vômitos e/ou diarreia (p. ex., gastroenterite). Outras fontes são perdas renais (p. ex., cetoacidose diabética), cutâneas (p. ex. sudorese abundante ou queimaduras) e no 3º espaço (p. ex., no lúmen intestinal na obstrução intestinal ou do íleo).

5. SINAIS E SINTOMAS

· **Insolação (Heatstroke):** Hipertermia ($>40^{\circ}\text{C}$), pele quente/seca (ausência de suor em estágios tardios), alteração de consciência e taquicardia severa.

· **Desidratação Térmica:** Sede intensa, urina concentrada (oligúria), irritabilidade e mucosas secas, sem necessariamente haver diarreia.

Os sinais e sintomas da desidratação variam de acordo com o grau do déficit e com o nível sérico de sódio.

Os principais sinais e sintomas são: sede, letargia, mucosa seca, oligúria, podendo evoluir para taquicardia, hipotensão e choque.

Pode-se estimar a perda hídrica pelos sinais e sintomas que a criança apresentar:

Gravidade	Déficit de líquidos em mL/kg (percentual do peso corporal)*		Sinais†
	Lactentes	Adolescentes	
Leve	50 (5%)	30 (3%)	Tipicamente resultados mínimos, mas pode ter mucosa bucal pouco seca, aumento da sede, diurese levemente diminuída.
Moderada	100 (10%)	50–60 (6%)	(5–6%) Mucosa oral seca, taquicardia, diminuição ou ausência de diurese, letargia, olhos encovados e fontanela deprimida, perda do turgor da pele.
Grave	150 (15%)	70–90 (9%)	(7–9%) Semelhantes ao moderado, somados a pulso fino e rápido, ausência de lágrimas, cianose, taquipneia, fluxo capilar

retardado, hipotensão, pele reticulada, coma.

Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/pediatria/desidrata%C3%A7%C3%A3o-e-fluidoterapia-em-crian%C3%A7as> – consulta em 27/12/2025

Recomenda-se a coleta de eletrólitos para crianças moderada ou gravemente desidratadas, quando são mais comuns os distúrbios eletrolíticos (p. ex., sódio elevado, potássio baixo, acidose metabólica) e para crianças que precisam de terapia IV com líquidos. Outras anormalidades laboratoriais na desidratação incluem aumento relativo do hematócrito resultante da hemoconcentração, ureia plasmática elevada e aumento da densidade urinária.

SÓDIO ELEVADO

Por causa do deslocamento de líquido para fora do interstício e *para dentro* do espaço vascular, crianças com hipernatremia *parecem* mais enfermas (p. ex., com mucosas muito secas, aparência pastosa da pele) para um determinado grau de perda de água do que crianças com hiponatremia. Mas crianças com hipernatremia têm melhor hemodinâmica (p. ex., menos taquicardia, melhor débito urinário) do que crianças com hiponatremia, nas quais o líquido se deslocou para *fora* do espaço vascular.

SÓDIO DIMINUÍDO

Crianças desidratadas com hiponatremia podem parecer apenas levemente desidratadas, mas realmente estão mais próximas da hipotensão e do colapso cardiovascular do que as crianças desidratadas com níveis de sódio normais ou elevados.

6. RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO

A quantidade de líquidos, a composição e a taxa de reposição podem diferir para cada um. As fórmulas e as estimativas utilizadas para estabelecer parâmetros de tratamento fornecem um ponto de partida, mas o tratamento precisa de monitoramento contínuo dos sinais vitais, aspecto clínico, débito urinário, peso e, às vezes, níveis de eletrólitos no soro.

PLANO A: Prevenção (Paciente Eutrófico e Hidratado)

- **Local:** Domicílio.
- **Conduta:** Oferecer Soro de Reidratação Oral (SRO) após cada exposição prolongada ao sol ou atividades físicas.
- **Volumes sugeridos:** * Até 2 anos: 50–100 mL.
- Acima de 2 anos: 100–200 mL.
- **Orientação:** Evitar bebidas com alto teor de açúcar (refrigerantes/sucos artificiais), que podem causar diarreia osmótica e piorar o quadro.

PLANO B: Desidratação Leve a Moderada

Indicado para crianças com sinais clínicos (olhos encovados, sede ávida, sinal da prega presente).

Manter a criança ainda na unidade de atendimento.

1. **Oferta de SRO:** Administrar **50 a 100 mL/kg** em um período de **3 a 4 horas**.
2. **Técnica:** Oferecer em pequenas quantidades (colher ou copo) a cada 2–5 minutos. O SRO deve estar, preferencialmente, **gelado** para aumentar a aceitação e ajudar na termorregulação.

3. **Avaliação:** Reavaliar a cada 1 hora. Se houver desaparecimento dos sinais, passar para o Plano A.
4. **Uso de Antieméticos:** Em caso de vômitos que impedem a TRO, utilizar anti-hemético, aguardar 30 minutos e reiniciar a oferta oral.

PLANO C: Desidratação Grave / Choque Térmico

- **Local:** Sala Vermelha.
- **Conduta:** Acesso venoso imediato com **Soro Fisiológico 0,9% (20 mL/kg)** em bolus rápido (até 20 min).
- **Particularidade do Calor:** Em casos de insolação grave, resfriar o paciente simultaneamente (compressas frias e ventilação).

7. RECOMENDAÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS QUE FARÃO TRATAMENTO EM CASA

Monitoramento da Diurese: Instruir os responsáveis a observar o número de fraldas trocadas (mínimo de 4 a 6 por dia).

Aleitamento: Reforçar que bebês em aleitamento materno exclusivo não precisam de água, mas a mãe deve aumentar sua própria hidratação e oferecer o peito com maior frequência.

8. RECOMENDAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE SINAIS DE ALERTA

Sinais de Alerta para Internação

- Alteração do estado de consciência (apatia ou coma).
- Incapacidade de ingestão oral (vômitos incoercíveis).
- Ausência de diurese por mais de 6 horas.
- Sinais de choque (tempo de enchimento capilar > 3 segundos).

ANEXO I – DILUIÇÃO DO SACHE DE SRO (Natulab)

Composição do sachê da Natulab s 27,9g segue a proporção para 1 litro que resulta em:

- Cloreto de Sódio: 3,5g
- Citrato de Sódio Di-hidratado: 2,9g
- Cloreto de Potássio: 1,5g
- Glicose: 20,0g

1. Instrução de diluição correta

O sachê de **27,9g** da Natulab é formulado para ser diluído em exatamente **1000 mL (1 litro)** de água filtrada ou fervida.

ALERTA TÉCNICO: Nunca dilua o sachê em volumes menores (ex: um copo d'água), pois isso cria uma solução hipertônica que pode piorar a desidratação ao causar diarreia osmótica.

2. Cálculo da Quantidade de SRO

Para profissionais nas emergências do RJ, o cálculo deve seguir a recomendação de **50 a 100 mL por quilo de peso**, para ser administrado no período de **3 a 4 horas**.

Fórmula de Bolso:

Volume Total (mL) = Peso da criança (kg) x (50 a 100)

Exemplo:

3 kg - 150 - 300 mL

5 kg - 250 a 500 mL

10 - 500 a 1000 mL

15 kg - 750 a 1500 mL

20 kg - 1000 a 2000 mL

25 k - g 1250 - 2500 mL

ANEXO II – GUIA DE RECOMENDAÇÕES E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS PARA OS CUIDADORES DAS CRIANÇAS

1. Meu filho não está com diarreia, ele pode desidratar mesmo assim?

Sim. No calor forte do Rio, a criança perde muita água pelo suor e pela respiração acelerada. Se ela não beber água na mesma velocidade em que perde, o corpo desidrata. É a chamada "desidratação térmica".

2. Qual a melhor forma de oferecer o Soro de Reposição Oral (SRO)?

O segredo é a paciência. Ofereça de **colher em colher** ou em pequenos goles a cada 2 ou 5 minutos.

· **Dica de ouro:** No calor, você pode oferecer o soro **gelado**. Isso ajuda a baixar a temperatura do corpo e é melhor aceito pela criança.

3. Posso dar sucos, refrigerantes ou bebidas esportivas (isotônicos comuns)?

Não é recomendado. Essas bebidas têm muito açúcar, o que pode "puxar" mais água do corpo para o intestino e causar diarreia, piorando a desidratação. O ideal é o Soro da Unidade de Saúde, água e sucos naturais sem açúcar.

4. Como saber se meu filho está hidratado?

O melhor sinal é o **XIXI**. Se a criança estiver urinando várias vezes ao dia (pelo menos 4 a 6 fraldas ou idas ao banheiro), com urina clarinha e sem cheiro forte, ela está bem. Se o xixi estiver pouco e muito escuro, aumente a oferta de líquidos.

5. Meu filho ainda mama no peito. Preciso dar água ou soro?

- **Bebês menores de 6 meses (em peito exclusivo):** Não precisam de água ou soro, mas precisam mamar com **muito mais frequência**. A mãe também deve beber muita água.
- **Bebês que já comem:** Ofereça água e soro nos intervalos das refeições.

6. Quando devo voltar correndo para a Emergência?

Retorne imediatamente se observar:

- Criança muito "caidinha", sonolenta ou difícil de acordar.
- Muita sede, mas a criança não consegue mais beber nada.
- Vômitos que não param (ela coloca tudo para fora).
- Olhos fundos e ausência de lágrimas quando ela chora.
- Mais de 6 horas sem fazer xixi.

7. Como evitar que isso aconteça de novo nos dias de calor?

- Mantenha a criança em locais arejados e à sombra.
- Use roupas leves, de algodão e cores claras.
- Ofereça água mesmo que a criança não peça.
- Evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h.

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia prático de manejo da diarreia aguda. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 27 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância e controle de doenças transmitidas por alimentos. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2022.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Saúde. Protocolos de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) em Pediatria. Rio de Janeiro: SES-RJ, 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Gastroenterite Aguda: Guia Prático de Atualização. Departamento Científico de Gastroenterologia. São Paulo: SBP, out. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Hidratação no paciente pediátrico e riscos da exposição ao calor extremo**. Departamento Científico de Nutrologia e Emergência. São Paulo: SBP, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers**. 4th rev. Geneva: WHO Press, 2005. (Reafirmado em 2023).

Rio de Janeiro, 29 dezembro de 2025

CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO

Secretária de Estado de Saúde

Id Funcional nº 564046-6



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Maria Braga de Mello, Secretária de Estado**, em 29/12/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **121791282** e o código CRC **C6F3580C**.

Referência: Processo nº SEI-080001/045039/2025

SEI nº 121791282

Rua Barão de Itapagipe, 225, 4º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20261-005

Telefone: 3385-9000 - www.saude.rj.gov.br